

Buku Monograf **PENGEMBANGAN HOME CARE**

**PERAWATAN MANDIRI DI RUMAH UNTUK PENINGKATAN
KEMANDIRIAN LANSIA DENGAN DEMENSA**

Dr. Hidayatus Sya'diyah, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Monograf:

**Pengembangan *Home Care*:
Perawatan Mandiri di Rumah
untuk Peningkatan
Kemandirian Lansia
dengan Demensia**

Dr. Hidayatus Sya'diyah, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU MONOGRAF

Pengembangan Home Care: Perawatan Mandiri di Rumah untuk Peningkatan Kemandirian Lansia dengan Demensia

Penulis:

Dr. Hidayatus Sya'diyah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Achmad Faisal

Cetakan Pertama, Maret 2026

ISBN: 978-634-7556-83-7

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, RT. 001 RW. 005,

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

www.optimaluntuknegeri.com

Instagram: @optimal.penerbit & @bimbel.optimal

Tiktok: @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku Monograf **“Pengembangan Home Care: Perawatan Mandiri di Rumah untuk Peningkatan Kemandirian Lansia dengan Demensia”**. Monograf ini, mengelaborasi sebagian permasalahan dan hasil penelitian, meliputi variabel *home care* dan kemandirian lansia. *Home care* merupakan pemberian layanan keperawatan di rumah mencakup layanan untuk klien di rumah yang diperlukan untuk mempertahankan, memulihkan, meningkatkan kesehatan fisik, psikologis dan sosial. Fokus keperawatan kesehatan di rumah adalah individu dan keluarga mereka.

Rumah adalah teritori keluarga, isu kekuatan dan kendali dalam pemberian asuhan. Kebutuhan perawatan di rumah dapat diidentifikasi oleh siapapun yang terlibat dengan klien antara lain pasangan, anak kandung, saudara, dll. *Home care* yang dilakukan berbasis pemberdayaan keluarga (*caregiver empowerment*) untuk meningkatkan kemandirian lansia demensia dan masih perlu diketahui lebih lanjut.

Monograf ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam memahami secara kongkrit upaya perawatan pada lansia demensia melalui *home care* atau perawatan di rumah yang dilakukan oleh keluarga sehingga mendukung perawatan bagi lansia demensia dan menciptakan kemandirian lansia demensia.

Kemanfaatan lebih luas adalah menginspirasi semua anggota keluarga berperan secara aktif dalam melakukan perawatan lansia demensia. Semoga buku ini, dapat menambah ilmu dan wacana praktis bidang kesehatan khususnya dalam keperawatan geriatri.

Januari, 2026

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Konsep Lansia	4
A. Pengertian Lansia	4
B. Batasan Lansia	5
C. Teori Proses Menua	6
D. Perubahan-Perubahan pada Lansia.....	8
BAB 3 Konsep Demensia.....	12
A. Pengertian Demensia	12
B. Epidemiologi Demensia	13
C. Klasifikasi Demensia	14
D. Faktor Penyebab Demensia.....	15
E. Gejala Demensia.....	16
F. Tahapan Demensia	20
G. Perawatan Demensia.....	22
BAB 4 Home Care	25
A. Definisi <i>Home Care</i>	25
B. Sejarah Perkembangan <i>Home Care</i>	26
C. Pentingnya <i>Home Care</i>	29
D. Manfaat <i>Home Care</i>	30
E. Prinsip Utama <i>Home Care</i>	30
F. Jenis Layanan <i>Home Care</i>	30
G. Jenis Institusi Pemberi Layanan <i>Home Care</i>	31

H. Populasi Pemberi Layanan Home Care	33
I. Model <i>Long Term Home Care</i>	35
BAB 5 Kemandirian Lansia Demensia.....	38
A. Definisi Kemandirian	38
B. Aspek-Aspek Kemandirian	42
C. Jenis Kemandirian	48
D. Karakteristik Kemandirian	48
E. Bentuk-Bentuk Kemandirian	49
F. Ciri dan Tingkatan Kemandirian.....	50
G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian.....	52
H. Strategi Mendukung Kemandirian.....	54
BAB 6 Home Care Mendukung Kemandirian.....	56
BAB 7 Penutup	65
 Daftar Pustaka	 67
Glosarium	69
Profil Penulis	71



BAB 1

Pendahuluan

Peningkatan jumlah kasus lansia demensia menjadi fenomena menarik yang terjadi di beberapa negara ditandai dengan penurunan fungsi otak, memori, kemampuan kognitif yang hilang secara progresif. Penurunan fungsi kognitif pada lansia berpengaruh terhadap aktifitas sosial dan kemandirian lansia berdampak pada aktifitas sehari-hari seperti pergi ke toilet, berdandan, dan makan. Demensia menjadi salah satu penyakit degeneratif yang memerlukan perawatan jangka waktu lama (*long term care*).

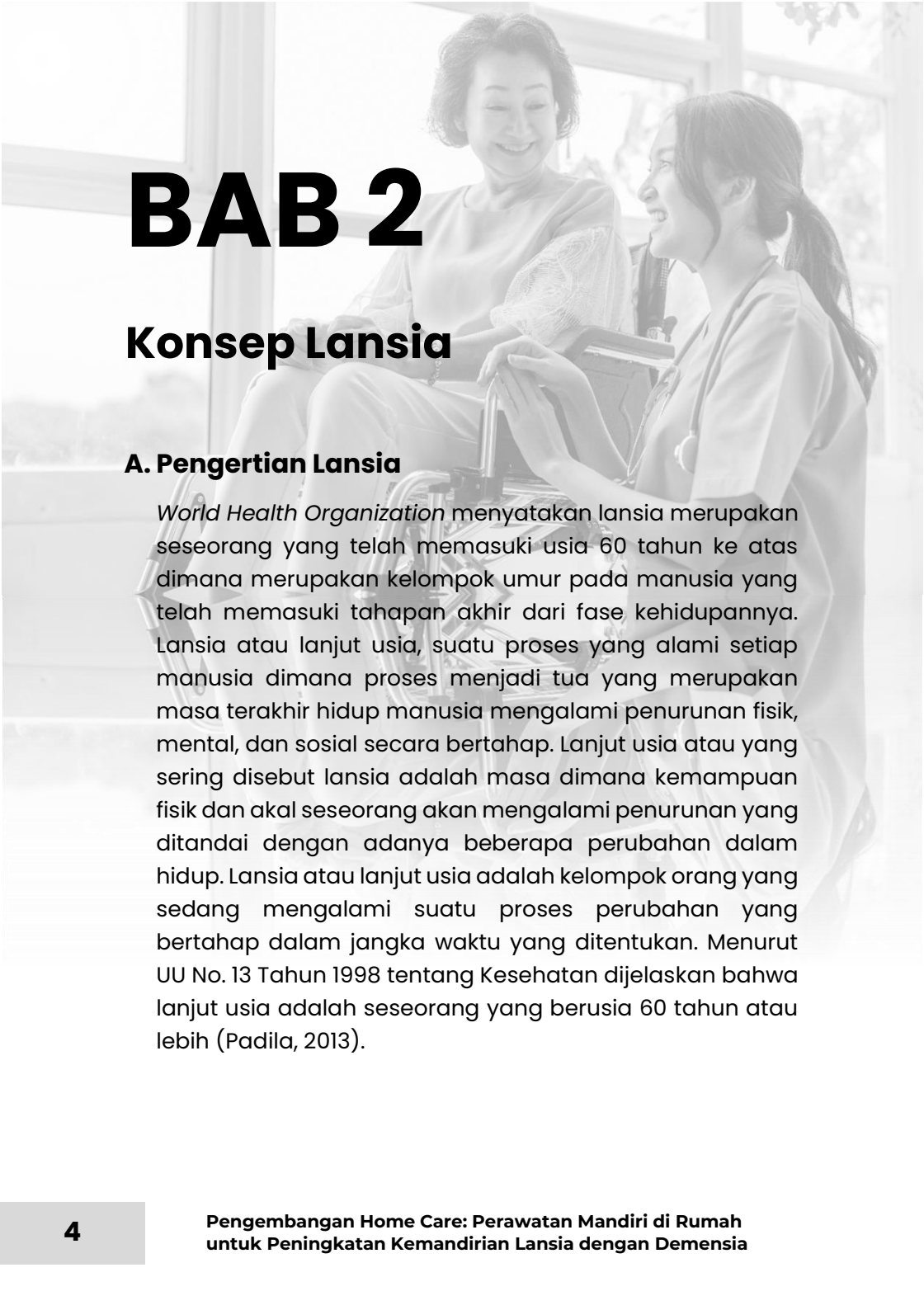
Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perawatan lansia seperti pengambilan keputusan, perawatan berdasarkan budaya, memberikan dukungan bagi lansia demensia. Beberapa lansia memutuskan bertahan di rumah atau berpindah ke alternatif tempat lain, dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Ulasan terbanyak, lansia berada di rumah akan mendukung kemandirian hidupnya sehingga perawatan kesehatan lansia diutamakan tetap berada dalam lingkungan keluarga melalui perawatan di rumah.

Oleh karena itu pengembangan *home care* oleh keluarga untuk meningkatkan kemandirian lansia demensia masih perlu diketahui lebih lanjut. Tujuan penulisan ini adalah menunjukkan bahwa pengembangan *home care* oleh keluarga mampu meningkatkan kemandirian lansia demensia.

Keluarga sebagai pusat keperawatan didasarkan pada perspektif bahwa keluarga adalah unit dasar untuk perawatan individu dari anggota keluarga dan dari unit yang lebih luas. Keluarga adalah unit dasar dari sebuah komunitas dan masyarakat, mempresentasikan perbedaan budaya, rasial, etnik, dan sosioekonomi. Pengkajian pada keluarga perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor lansia (fisik, emosional, sosial, spiritual); faktor keluarga (sosial budaya, lingkungan, struktur dan peran, stres dan coping keluarga) sedangkan faktor pelayanan kesehatan (akses, petugas kesehatan, sarana prasarana) (Kholifah, 2016).

Keluarga memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Keluarga merupakan *entry point* dalam memberikan pelayanan keperawatan di masyarakat, keterlibatan seluruh anggota keluarga sangatlah dibutuhkan dalam memberikan bantuan kesehatan dan melakukan upaya pencegahan penyakit seperti luka diabetik.

Kemandirian pada lansia mengandung pengertian yaitu kemampuan yang dimiliki oleh lansia untuk tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitasnya, semuanya dilakukan sendiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Menurut Parker faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia salah satunya adalah dukungan sosial dari keluarga.



BAB 2

Konsep Lansia

A. Pengertian Lansia

World Health Organization menyatakan lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dimana merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Lansia atau lanjut usia, suatu proses yang alami setiap manusia dimana proses menjadi tua yang merupakan masa terakhir hidup manusia mengalami penurunan fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Lanjut usia atau yang sering disebut lansia adalah masa dimana kemampuan fisik dan akal seseorang akan mengalami penurunan yang ditandai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Lansia atau lanjut usia adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih (Padila, 2013).

Penuaan merupakan proses yang terjadi secara alamiah yang seringkali dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis (Mustika, 2019). Menua merupakan suatu keadaan yang terjadi di kehidupan manusia. Menjadi tua merupakan salah satu proses alamiah, dimana seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa kanak-kanak, dewasa dan lansia (Mawaddah, 2020).

Lansia merupakan kelompok manusia yang telah memasuki fase akhir dalam kehidupannya, dimana pada fase ini lansia akan mengalami proses degeneratif atau proses penuaan (Manurung *et al*, 2020). Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, seseorang yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi (Ratnawati, 2017).

B. Batasan Lansia

1. Menurut World Health Organization (WHO, 2017) batasan lanjut usia dikelompokkan menjadi empat kelompok diantaranya:
 - a. Lansia pertengahan (*Middle age*) berusia antara 45 - 59 tahun
 - b. Lansia (*Elderly*) berusia antara 60 - 74 tahun
 - c. Lansia tua (*Old*) berusia antara 75 - 90 tahun
 - d. Lansia sangat tua (*Very Old*) berusia > 90 tahun. Dan Depatemen Sosial mengambil batasan umur lansia adalah 60 tahun ke atas

2. Menurut Depkes RI (2019), batasan lanjut usia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok diantaranya:
 - a. Pra lansia adalah seseorang yang berusia antara 45 – 59 tahun
 - b. Lansia adalah seseorang yang berusia > 60 tahun
 - c. Lansia dengan risiko tinggi adalah seseorang yang berusia > 60 tahun dengan masalah kesehatan
 - d. Lansia potensial adalah lansia yang masih bisa melakukan kegiatannya sehari-hari dan masih mampu menghasilkan barang atau jasa
 - e. Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya dan tidak mampu melakukan kegiatannya sehari-hari sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

C. Teori Proses Menua

Dalam penelitian Damanik (2019), teori proses menua terbagi menjadi beberapa bagian menurut para ahli yaitu:

1. Teori biologi
 - a. Teori genetik dan mutasi
Penuaan terjadi secara genetik pada spesies tertentu dan dapat terjadi karena perubahan biokimia oleh DNA dan dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsional sel.
 - b. Teori kerusakan pada sel
Stress berkelanjutan yang dialami oleh tubuh menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel tubuh.

- c. Teori sistem kekebalan tubuh dan reaksi
Pada proses metabolisme tubuh yang memproduksi zat khusus pada jaringan tubuh tertentu, menyebabkan jaringan tersebut tidak mampu menahan zat yang di produksi sehingga mengakibatkan jaringan tubuh menjadi lemah dan sakit.
- d. Teori *immunology slow virus*
Sistem imun yang menjadi efektif seiring dengan bertambahnya usia seseorang dan masuknya virus kedalam tubuh sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ tubuh.
- e. Teori stres
Menua dapat terjadi karena hilangnya sel-sel yang digunakan oleh tubuh. Regenerasi yang tidak mampu mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha dan faktor stress mengakibatkan sel-sel tubuh menjadi rusak.
- f. Teori radikal bebas
Ketidakstabilan radikal bebas (kelompok atom) yang tidak dapat diserap oleh tubuh, berdampak pada kerusakan sel-sel tubuh.
- g. Teori rantai silang
Reaksi kimia menyebabkan ikatan yang kuat dan menyebabkan terjadinya penurunan elastisitas pada kulit.
- h. Teori program
Kemampuan organisme menetapkan jumlah sel yang membelah setelah sel-sel tersebut mati.

2. Teori kejiwaan sosial

a. Teori aktivitas

Lansia akan mengalami penurunan jumlah kegiatan yang dilakukannya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa, lansia yang sukses adalah lansia yang aktif serta mau mengikuti banyak kegiatan sosial.

b. Teori kepribadian berlanjut

Perubahan terhadap kepribadian dan tingkah laku lansia seringkali dipengaruhi oleh tipe personality yang dimilikinya.

c. Teori kebebasan

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka seseorang tersebut akan mulai melepaskan diri dari lingkungan sosial. Dimana keadaan tersebut menyebabkan penurunan terhadap interaksi sosial pada lansia diantaranya:

- 1) Kehilangan peran
- 2) Hambatan kontak sosial
- 3) Berkurangnya kontak komitmen

D. Perubahan-Perubahan pada Lansia

Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan terjadi proses penuaan secara degeneratif yang seringkali berdampak pada perubahan-perubahan pada jiwa maupun diri manusia, tidak hanya perubahan fisik namun juga perubahan pada kognitif, perasaan, sosial dan seksual (National & Pillars, 2020).

1. Perubahan fisik

a. Sistem keseluruhan

Penurunan tinggi badan dan berat badan dan berkurangnya cairan tubuh

- b. Sistem pendengaran
Prebiakusis (gangguan pada pendengaran) yang terjadi karena hilangnya kemampuan pendengaran pada telinga bagian dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada tinggi, suara yang tidak jelas, kata-kata yang sulit dimengerti yang seringkali terjadi pada lansia > 60 tahun.
- c. Sistem integumen
Kulit lansia mengalami atropi, kendur, tidak elastis, kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan berbekak.
- d. Sistem muscular
Kecepatan dan kekuatan kontraksi otot skeletal berkurang, pengecilan otot karena menurunnya serabut otot, tetapi tidak mempengaruhi otot polos.
- e. Sistem kardiovaskular
Massa jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertropi serta kemampuan peregangan jantung berkurang karena perubahan pada jaringan ikat, penumpukan lipofusin, klasifikasi SA node dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan ikat.
- f. Sistem perkemihan
Ginjal mengecil, penurunan aliran darah ke ginjal, filtrasi glomerulus menurun, kapasitas kandung kemih menurun karena otot-otot melemah, frekuensi berkemih meningkat.
- g. Sistem pernafasan
Otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, menurunnya aktivitas silia, berkurangnya elastisitas paru, melebarnya ukuran paru, jumlah alveoli yang berkurang, berkurangnya maximal oksigen *uptake*.

h. Sistem gastrointestinal

Penurunan indera pengecap karena adanya iritasi kronis dari selaput lendir, penurunan sensitifitas saraf pengecap di lidah (rentang rasa asin, asam dan pahit). Pada lambung, sensitifitas lapar menurun, asam lambung menurun.

i. Sistem penglihatan

Perubahan sistem penglihatan pada lansia berkaitan dengan presbiopi (berkurangnya luas pandang, berkurangnya sensitifitas terhadap warna, menurunnya kemampuan dalam membedakan warna).

j. Sistem persyarafan

Penurunan sensitifitas sentuhan, berkurangnya berat otak menjadi 10-2-%, kemunduran fungsi saraf otonom.

2. Perubahan kognitif

Pada lansia, seringkali memori jangka pendek, pikiran, kemampuan berbicara serta kemampuan motorik terpengaruh. Dimana lansia akan kehilangan kemampuan dan pengetahuan yang didapatkan sebelumnya serta cenderung akan mengalami demensia.

3. Perubahan psikososial

a. Kesepian

Terjadi pada saat kehilangan pasangan hidup atau teman dekatnya terutama jika lansia mengalami penurunan kesehatan, seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan mobilitas maupun gangguan sensorik (pendengaran).

b. Gangguan kecemasan

Terbagi menjadi beberapa golongan yaitu fobia, panik, gangguan kecemasan umum, gangguan stress setelah trauma serta gangguan obsesif kompulsif. Gangguan- gangguan tersebut seringkali berhubungan dengan penyakit medis, depresi, efek samping obat maupun gejala penghentian mendadak dari pemakaian obat.

c. Gangguan tidur

Gangguan tidur pada lansia dikenal sebagai penyebab morbiditas yang menimbulkan beberapa dampak seperti mengantuk berlebihan pada siang hari, gangguan atensi dan memori, mood depresi, sering terjatuh dan penurunan kualitas hidup.



BAB 3

Konsep Demensia

A. Pengertian Demensia

Demensia adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan fungsi kognitif global yang biasanya bersifat progresif dan mempengaruhi aktivitas sosial dan okupasi yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit yang menyebabkan gejala demensia antara lain Alzheimer, masalah vaskuler, Parkinson, alkoholisme kronis, penyakit Pick, penyakit Huntington, dan AIDS. Sedikitnya setengah dari penghuni panti jompo menderita Demensia. Demensia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menghabiskan banyak biaya dalam perawatannya. Demensia merupakan penyakit degeneratif yang memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama dialami oleh sejumlah penduduk usia lanjut (lebih dari 60 tahun) (Vega Dela *et al.*, 2018). Demensia dapat diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penderita demensia seringkali menunjukkan beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian (*behavioral symptom*) yang mengganggu (*disruptive*) ataupun tidak mengganggu (*non-disruptive*).

Demensia bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi tertentu sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah laku (Barker S, 2019).

Demensia adalah satu penyakit yang melibatkan sel-sel otak yang mati secara abnormal. Hanya satu terminologi yang digunakan untuk menerangkan penyakit otak degeneratif yang progresif. Daya ingat, pemikiran, tingkah laku dan emosi akan menunjukkan gejala bila mengalami demensia. Penyakit ini bisa dialami oleh semua orang dari berbagai latar belakang pendidikan maupun kebudayaan (Barker S, 2019).

B. Epidemiologi Demensia

Pada tahun 2021, 57 juta orang di seluruh dunia menderita demensia, lebih dari 60% di antaranya tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setiap tahun, terdapat hampir 10 juta kasus baru. Demensia disebabkan oleh berbagai penyakit dan cedera yang memengaruhi otak. Penyakit Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling umum dan dapat menyumbang 60–70% kasus. Saat ini, demensia merupakan penyebab kematian ketujuh terbesar dan salah satu penyebab utama kecacatan dan ketergantungan di kalangan lansia di seluruh dunia.

Pada tahun 2019, demensia menelan biaya ekonomi global sebesar US\$ 1,3 triliun, dan sekitar 50% dari biaya tersebut disebabkan oleh perawatan yang diberikan oleh pengasuh informal (misalnya anggota keluarga dan teman dekat), yang rata-rata memberikan 5 jam perawatan dan pengawasan per hari.

Perempuan terkena dampak demensia secara tidak proporsional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan mengalami tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan (disability-adjusted life years) dan angka kematian yang lebih tinggi akibat demensia, tetapi juga menyediakan 70% jam perawatan bagi orang yang hidup dengan demensia. (Oing Chao, et al, 2020).

C. Klasifikasi Demensia

Klasifikasi lansia dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. Menurut Umur:
 - a. Demensia senilis (>65 tahun)
 - b. Demensia prasenilis (<65 tahun)
 - c. Menurut perjalanan penyakit:
 - d. *Reversibel*
 - e. *Ireversibel* (*Normal pressure hydrocephalus*, subdural hematoma, vitamin B Defisiensi, Hipotiroidisma, intoksikasi Pb.
2. Menurut kerusakan struktur otak
 - a. Demensia vaskular
 - b. Demensia Jisim Lewy (*Lewy Body Dementia*)
 - c. Demensia lobus frontal-temporal

- d. Demensia terkait dengan HIV-AIDS
 - e. Morbus Parkinson
 - f. Morbus Huntington
 - g. Morbus Pick
 - h. Morbus Jakob-Creutzfeldt
 - i. Sindrom Gerstmann-Sträussler-Scheinker
 - j. Prion disease
 - k. Palsi Supranuklear progresif
 - l. Multiple sklerosis
 - m. Neurosifilis
 - n. Tipe campuran
3. Menurut sifat klinis:
- a. Demensia proprius
 - b. Pseudo-demensia (Barker S, 2019)

D. Faktor Penyebab Demensia

Beberapa literatur menyebutkan bahwa penyakit yang dapat menyebabkan timbulnya gejala demensia ada sejumlah tujuh puluh lima. Beberapa penyakit dapat disembuhkan sementara sebagian besar tidak dapat disembuhkan. Sebagian besar peneliti dalam risetnya sepakat bahwa penyebab utama dari gejala demensia adalah penyakit Alzheimer, penyakit vascular (pembuluh darah), demensia Lewy body, demensia frontotemporal dan sepuluh persen diantaranya disebabkan oleh penyakit lain.

Lima puluh sampai enam puluh persen penyebab demensia adalah penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah kondisi dimana sel syaraf pada otak mati sehingga membuat signal dari otak tidak dapat ditransmisikan

sebagaimana mestinya. Penderita Alzheimer mengalami gangguan memori, kemampuan membuat keputusan dan juga penurunan proses berpikir (Barker S, 2019).

Beberapa hal yang meningkatkan risiko terkena demensia meliputi:

1. Usia (lebih umum terjadi pada mereka yang berusia 65 tahun ke atas)
2. Tekanan darah tinggi (hipertensi)
3. Gula darah tinggi (diabetes)
4. Kelebihan berat badan atau obesitas
5. Merokok
6. Minum terlalu banyak alkohol
7. Kurang aktif secara fisik
8. Terisolasi secara sosial
9. Depresi

E. Gejala Demensia

Adapun tanda dan gejala awal meliputi:

1. Melupakan sesuatu atau kejadian baru-baru ini
2. Kehilangan atau salah menaruh barang
3. Tersesat saat berjalan kaki atau mengemudi
4. Merasa bingung, bahkan di tempat-tempat yang sudah dikenal.
5. Kehilangan jejak waktu
6. Kesulitan dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan
7. Kesulitan mengikuti percakapan atau kesulitan menemukan kata-kata
8. Kesulitan melakukan tugas-tugas yang sudah biasa
9. Salah memperkirakan jarak ke objek secara visual.

Perubahan suasana hati dan perilaku yang umum meliputi:

1. Merasa cemas, sedih, atau marah karena kehilangan ingatan
2. Perubahan kepribadian
3. Perilaku yang tidak pantas
4. Pengunduran diri dari pekerjaan atau kegiatan sosial
5. Kurang tertarik pada emosi orang lain.

Ada dua tipe demensia yang paling banyak ditemukan, yaitu tipe Alzheimer dan Vaskuler, antara lain:

1. Demensia Alzheimer

Gejala klinis demensia Alzheimer merupakan kumpulan gejala demensia akibat gangguan neuro degeneratif (penuaan saraf) yang berlangsung progresif lambat, dimana akibat proses degeneratif menyebabkan kematian sel-sel otak yang masif. Kematian sel-sel otak ini baru menimbulkan gejala klinis dalam kurun waktu 30 tahun. Awalnya ditemukan gejala mudah lupa (*forgetfulness*) yang menyebabkan penderita tidak mampu menyebut kata yang benar, berlanjut dengan kesulitan mengenal benda dan akhirnya tidak mampu menggunakan barang-barang sekalipun yang termudah. Hal ini disebabkan adanya gangguan kognitif sehingga timbul gejala neuropsikiatrik seperti, wahan (curiga, sampai menuduh ada yang mencuri barangnya), halusinasi pendengaran atau penglihatan, agitasi (gelisah, mengacau), depresi, gangguan tidur, nafsu makan dan gangguan aktifitas psikomotor, berkelana.

Stadium demensia Alzheimer terbagi 3 stadium, yaitu:

a. Stadium I

Berlangsung 2-4 tahun disebut stadium amnestik dengan gejala gangguan memori, berhitung dan aktifitas spontan menurun. Fungsi memori yang terganggu adalah memori baru atau lupa hal baru yang dialami.

b. Stadium II

Berlangsung selama 2-10 tahun, dan disebut stadium demensia. Gejalanya antara lain, disorientasi.

- 1) Gangguan bahasa (afasia)
- 2) Penderita mudah bingung
- 3) Penurunan fungsi memori lebih berat sehingga penderita tak dapat melakukan kegiatan sampai selesai, tidak mengenal anggota keluarganya tidak ingat sudah melakukan suatu tindakan sehingga mengulangnya lagi.
- 4) Gangguan visuospasial, menyebabkan penderita mudah tersesat di lingkungannya, depresi berat prevalensinya 15-20%.

c. Stadium III

Stadium ini dicapai setelah penyakit berlangsung 6-12 tahun. Gejala klinisnya antara lain:

- 1) Penderita menjadi vegetatif
- 2) Tidak bergerak dan membisu
- 3) Daya intelektual serta memori memburuk sehingga tidak mengenal keluarganya sendiri
- 4) Tidak bisa mengendalikan buang air besar/ kecil
- 5) Kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain
- 6) Kematian terjadi akibat infeksi atau trauma

2. Demensia Vaskuler

Untuk gejala klinis demensia tipe vaskuler, disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah di otak. Setiap penyebab atau faktor resiko stroke dapat berakibat terjadinya demensia. Depresi bisa disebabkan karena lesi tertentu di otak akibat gangguan sirkulasi darah otak, sehingga depresi itu dapat didiuga sebagai demensia vaskuler. Gejala depresi lebih sering dijumpai pada demensia vaskuler daripada Alzheimer. Hal ini disebabkan karena kemampuan penilaian terhadap diri sendiri dan respon emosi tetap stabil pada demensia vaskuler. Dibawah ini merupakan klasifikasi penyebab demensia vaskuler, diantaranya:

a. Kelainan sebagai penyebab demensia:

- 1) Penyakit degenaratif
- 2) Penyakit serebrovaskuler
- 3) Keadaan anoksi/ cardiac arrest, gagal jantung, intoksi CO
- 4) Trauma otak
- 5) Infeksi (AIDS, ensefalitis, sifilis)
- 6) Hidrosefaulus normotensif
- 7) Tumor primer atau metastasis
- 8) Autoimun, vaskulitif
- 9) Multiple sclerosis
- 10) Toksik
- 11) Kelainan lain : epilepsi, stress mental, *heat stroke*, *whipple disease*

b. Kelainan/keadaan yang dapat menampilkan demensia

c. Gangguan psikiatrik:

- 1) Depresi
- 2) Anxietas
- 3) Psikosis

- d. Obat-obatan:
 - 1) Psikofarmaka
 - 2) Antiaritmia
 - 3) Antihipertensi
- e. Antikonvulsan
 - 1) Digitalis
- f. Gangguan nutrisi:
 - 1) Defisiensi B6 (Pelagra)
 - 2) Defisiensi B12
 - 3) Defisiensi asam folat
 - 4) Marchiava-bignami disease
- g. Gangguan metabolisme:
 - 1) Hiper/hipotiroidi
 - 2) Hiperkalsemia
 - 3) Hiper/hiponatremia
 - 4) Hipoglikemia
 - 5) Hiperlipidemia
 - 6) Hipercapnia
 - 7) Gagal ginjal
 - 8) Sindrom Cushing
 - 9) Addison's disesse
 - 10) Hippotituitaria
 - 11) Efek remote penyakit kanker (Barker S, 2019)

F. Tahapan Demensia

Menurut Barker S (2019), adapun tahapan demensia dibentuk dengan berbagai sistem klasifikasi antara lain:

- 1. Tahap awal
 - a. Perubahan alam perasaan atau kepribadian
 - b. Gangguan penilaian dan penyelesaian masalah
 - c. Konfusi tentang tempat/tersesat

- d. Konfusi tentang waktu
 - e. Kesulitan dengan angka, uang dan tagihan
 - f. Anomia ringan
 - g. Menarik diri/depresi
2. Tahap pertengahan
- a. Gangguan memori saat ini dan masa lalu
 - b. Anomia, agnosia, apraksia, afasia
 - c. Gangguan penilaian dan penyelesaian masalah yang parah
 - d. Konfusi tentang waktu dan tempat semakin memburuk
 - e. Gangguan persepsi
 - f. Kehilangan pengendalian impuls
 - g. Ansietas, gelisah, mengeluyur
 - h. Hiporealitas
 - i. Kemungkinan kecurigaan, delusi atau halusinasi
 - j. Konfabulasi
 - k. Gangguan kemampuan merawat diri yang sangat besar
 - l. Mulai terjadi inkontinensia, gangguan siklus tidur-bangun
3. Tahap akhir
- a. Gangguan yang parah pada semua kemampuan kognitif
 - b. Ketidakmampuan untuk mengenali keluarga dan teman-teman
 - c. Gangguan komunikasi yang parah (dapat menggerutu, mengeluh, menggumam)
 - d. Sedikitnya kapasitas perawatan diri
 - e. Inkontinensia kandung kemih dan usus
 - f. Kemungkinan menjadi hiperoral dan tangan yang aktif

- g. Penurunan nafsu makan, disfasia dan resiko aspirasi
- h. Depresi sistem imun yang menyebabkan meningkatnya resiko infeksi
- i. Gangguan mobilitas dengan hilangnya kemampuan untuk berjalan, kaku otot, paratonia
- j. Reflek menghisap dan menggenggam
- k. Menarik diri
- l. Gangguan siklus tidur-bangun, dengan peningkatan waktu tidur

G. Perawatan Demensia

Hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan perawatan demensia diantaranya adalah menjaga ketajaman daya ingat dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak, seperti:

1. Segi Kognitif
 - a. Membaca buku yang merangsang otak untuk berpikir hendaknya dilakukan setiap hari.
 - b. Melakukan kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat dan aktif
2. Segi Spiritual

Kegiatan rohani & memperdalam ilmu agama.
3. Segi Interaksi Sosial
 - a. Tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul dengan teman yang memiliki persamaan minat atau hobi
 - b. Mengurangi stress dalam pekerjaan dan berusaha untuk tetap relaks dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat

Tidak ada obat untuk demensia, tetapi banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendukung baik orang yang hidup dengan penyakit ini maupun mereka yang merawatnya. Penderita demensia dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara:

1. aktif secara fisik
2. Berpartisipasi dalam aktivitas dan interaksi sosial yang merangsang otak dan menjaga fungsi sehari-hari.

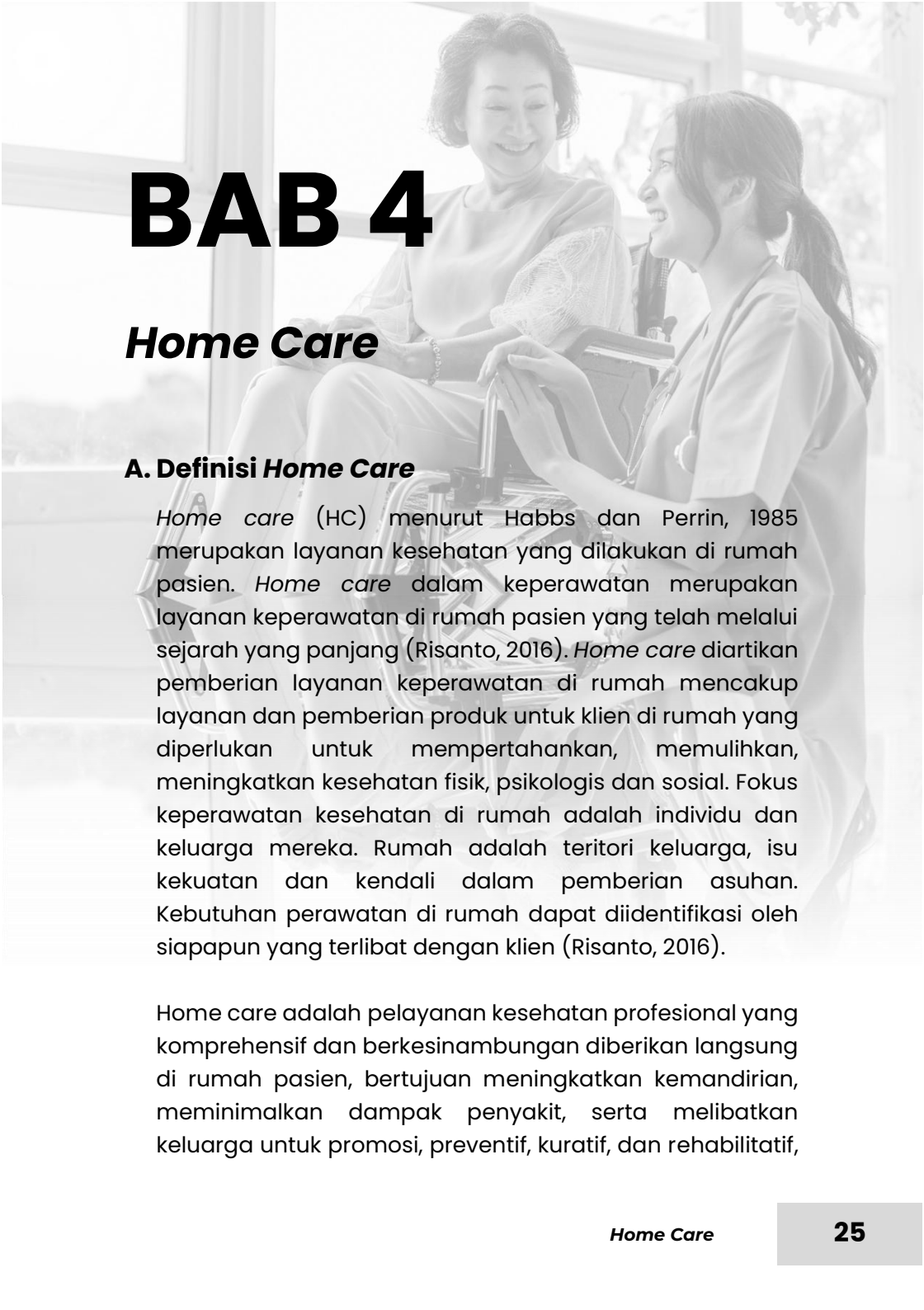
Bagi mereka yang didiagnosis menderita demensia, ada beberapa hal yang dapat membantu mengelola gejalanya:

1. Tetap aktif secara fisik.
2. Makan sehat.
3. Berhenti merokok dan minum alkohol.
4. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin dengan dokter Anda.
5. Catatlah tugas dan janji temu sehari-hari untuk membantu Anda mengingat hal-hal penting.
6. Teruslah menekuni hobi Anda dan lakukan hal-hal yang Anda sukai.
7. Cobalah cara-cara baru untuk menjaga pikiran Anda tetap aktif.
8. Luangkan waktu bersama teman dan keluarga serta terlibat dalam kehidupan komunitas.

Rencanakanlah jauh-jauh hari. Seiring waktu, mungkin akan lebih sulit untuk membuat keputusan penting bagi diri sendiri atau keuangan Anda:

1. Identifikasi orang-orang yang Anda percayai untuk mendukung Anda dalam mengambil keputusan dan membantu Anda mengkomunikasikan pilihan Anda.
2. Buatlah rencana terlebih dahulu untuk memberi tahu orang-orang tentang pilihan dan preferensi Anda terkait perawatan dan dukungan.
3. Bawalah kartu identitas yang berisi alamat dan kontak darurat Anda saat keluar rumah.
4. Hubungi keluarga dan teman untuk meminta bantuan.
5. Bicaralah dengan orang-orang yang Anda kenal tentang bagaimana mereka dapat membantu Anda.
6. Bergabunglah dengan kelompok dukungan lokal.

Penting untuk menyadari bahwa memberikan perawatan dan dukungan kepada seseorang yang hidup dengan demensia dapat menjadi tantangan, yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pengasuh itu sendiri. Sebagai seseorang yang mendukung orang yang hidup dengan demensia, hubungi anggota keluarga, teman, dan profesional untuk meminta bantuan. Istirahatlah secara teratur dan jaga diri Anda. Cobalah teknik manajemen stres seperti latihan berbasis mindfulness dan carilah bantuan serta bimbingan profesional jika diperlukan. (Syadiyah, H, 2019).



BAB 4

Home Care

A. Definisi *Home Care*

Home care (HC) menurut Habbs dan Perrin, 1985 merupakan layanan kesehatan yang dilakukan di rumah pasien. *Home care* dalam keperawatan merupakan layanan keperawatan di rumah pasien yang telah melalui sejarah yang panjang (Risanto, 2016). *Home care* diartikan pemberian layanan keperawatan di rumah mencakup layanan dan pemberian produk untuk klien di rumah yang diperlukan untuk mempertahankan, memulihkan, meningkatkan kesehatan fisik, psikologis dan sosial. Fokus keperawatan kesehatan di rumah adalah individu dan keluarga mereka. Rumah adalah teritori keluarga, isu kekuatan dan kendali dalam pemberian asuhan. Kebutuhan perawatan di rumah dapat diidentifikasi oleh siapapun yang terlibat dengan klien (Risanto, 2016).

Home care adalah pelayanan kesehatan profesional yang komprehensif dan berkesinambungan diberikan langsung di rumah pasien, bertujuan meningkatkan kemandirian, meminimalkan dampak penyakit, serta melibatkan keluarga untuk promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,

sebagai solusi mengatasi keterbatasan fasilitas rumah sakit dengan pendekatan multidisiplin dan berfokus pada kebutuhan individu serta konteks budaya pasien.

B. Sejarah Perkembangan *Home Care*

1. Luar Negeri

Home care di Amerika, yang terorganisasi dimulai sejak sekitar tahun 1880-an, dimana saat itu banyak sekali penderita penyakit infeksi dengan angka kematian yang tinggi. Pada saat itu telah banyak didirikan rumah sakit modern, namun pemanfaatannya masih sangat rendah, hal ini dikarenakan masyarakat lebih menyukai perawatan di rumah. Kondisi ini berkembang secara profesional, sehingga pada tahun 1900 terdapat 12.000 perawat terlatih di seluruh USA (*Visiting Nurses/VN*; memberikan asuhan keperawatan di rumah pada keluarga miskin, *Public Health Nurses*, melakukan upaya promosi dan prevensi untuk melindungi kesehatan masyarakat, serta yang melakukan asuhan keperawatan pasien dirumah sesuai kebutuhannya) (Risanto, 2016).

Sejak tahun 1990-an institusi yang memberikan layanan *home care* terus meningkat sekitar 10% pertahun dari semula layanan hanya diberikan oleh organisasi perawat pengunjung rumah (*VNA = Visiting Nurse Association*) dan pemerintah, kemudian berkembang layanan yang berorientasi profit (*Proprietary Agencies*) dan yang berbasis RS (*Hospital Based Agencies*) Kondisi ini terjadi seiring dengan perubahan sistem pembayaran jasa layanan *home*

care (dapat dibayar melalui pihak ke tiga/asuransi) dan perkembangan spesialisasi di berbagai layanan kesehatan termasuk berkembangnya *Home Health Nursing* yang merupakan spesialisasi dari *Community Health Nursing* (Risanto, 2016).

Home care di UK, berkembang secara profesional selama pertengahan abad 19, dengan mulai berkembangnya *District Nursing*, yang pada awalnya dimulai oleh para biarawati yang merawat orang miskin yang sakit di rumah. Kemudian mereka mulai melatih wanita dari kalangan menengah ke bawah untuk merawat orang miskin yang sakit, dengan pengawasan biarawati tersebut. Kondisi ini terus berkembang sehingga pada tahun 1992 ditetapkan peran *District Nurse* (DN) adalah

- a. Merawat orang sakit di rumah, sampai klien mampu mandiri
- b. Merawat orang sakaratul maut di rumah agar meninggal dengan nyaman dan damai
- c. Mengajarkan keterampilan keperawatan dasar kepada klien dan keluarga, agar dapat digunakan pada saat kunjungan perawat yang sudah berlalu.

Selain *District Nurse* (DN), di UK juga muncul perawat *Health Visitor* (HV) yang berperan sebagai *District Nurse* (DN) ditambah dengan peran lain ialah:

- a. Melakukan penyuluhan dan konseling pada klien, keluarga maupun masyarakat luas dalam upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan

- b. Memberikan saran dan pandangan bagaimana mengelola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

2. Dalam negeri

Layanan *Home Care* (HC) di Indonesia, dengan merawat pasien di rumah baik yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dilatih dan atau oleh tenaga keperawatan melalui kunjungan rumah secara perorangan, adalah merupakan hal biasa sejak dahulu kala. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam perawatan maternitas, dimana RS Budi Kemulyaan di Jakarta yang merupakan RS pendidikan bidan tertua di Indonesia, sejak berdirinya sampai sekitar tahun 1975 telah melakukan program *Home Care* (HC) yang disebut dengan “Partus Luar”. Dalam layanan “Partus Luar”, bidan dan siswa bidan RS Budi Kemulyaan melakukan pertolongan persalinan normal di rumah pasien, kemudian diikuti dengan perawatan nifas dan neonatal oleh siswa bidan senior (kandidat) sampai tali pusat bayi puput (lepas). Baik bidan maupun siswa bidan yang melaksanakan tugas “Partus Luar” dan tindak lanjutnya, harus membuat laporan tertulis kepada RS tentang kondisi ibu dan bayi serta tindakan yang telah dilakukan. Kondisi ini terhenti seiring dengan perubahan kebijakan Departemen Kesehatan yang memisahkan organisasi pendidikan dengan pelayanan (Risanto, 2016).

C. Pentingnya *Home Care*

Home care mendapat perhatian karena berbagai alasan, antara lain yaitu dapat memberikan manfaat bagi klien dan keluarga antara lain:

1. Membantu meringankan biaya rawat inap yang makin mahal, karena dapat mengurangi biaya akomodasi pasien, transportasi dan konsumsi keluarga
2. Mempererat ikatan keluarga, karena dapat selalu berdekatan pada saat anggota keluarga ada yang sakit
3. Merasa lebih nyaman karena berada di rumah sendiri

Berbagai alasan tersebut membuat program layanan *home care* mulai menjadi perhatian untuk dikembangkan guna meningkatkan kemandirian lansia demensia. Apabila *home care* dilakukan dan dimanajemen secara efektif akan dapat meningkatkan kemandirian baik bagi pasien maupun bagi pemberi asuhan (keluarga), hal ini juga dapat mendukung perkembangan yang baik bagi kognitif dan fungsi fisik pasien.

Penelitian yang dilakukan di tahun 2014, membuktikan bahwa pasien dewasa tua yang dilakukan perawatan di rumah dilaporkan memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi dan tingkat kesepian serta tingkat stres yang rendah, dibanding yang tidak dilakukan. Untuk mempertahankan kemandirian dan meningkatkan prognosis lansia demensia diperlukan perawatan yang melibatkan keluarga atau dilakukan berkelanjutan dan tidak terputus (Umegaki *et al.*, 2016).

D. Manfaat *Home Care*

1. Kenyamanan dan privasi pasien karena berada di lingkungan sendiri.
2. Mengurangi beban keluarga untuk sering ke rumah sakit.
3. Pelayanan yang personal dan sesuai budaya pasien (berdasarkan teori Leininger).
4. Mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi lebih lanjut

E. Prinsip Utama *Home Care*

1. Komprehensif: Mencakup berbagai aspek kesehatan (medis, sosial, rehabilitasi, edukasi).
2. Berkesinambungan: Pelayanan dilakukan secara teratur dan tidak terputus.
3. Berpusat pada Pasien & Keluarga: Menyesuaikan kebutuhan individu dan peran keluarga dalam perawatan.
4. Promotif & Preventif: Mengutamakan pencegahan dan peningkatan kesehatan.
5. Multidisiplin: Melibatkan berbagai tenaga profesional (dokter, perawat, fisioterapis, dll.).
6. Kemandirian: Membantu pasien mencapai tingkat kesehatan dan kemandirian optimal.

F. Jenis Layanan *Home Care*

Jenis layanan yang disediakan:

1. Asuhan Keperawatan: Rawat luka, perawatan diabetes, perawatan ibu & bayi.
2. Layanan Medis: Kunjungan dokter, vaksinasi, tes laboratorium, medical check-up.

3. Rehabilitasi: Fisioterapi untuk pemulihan fungsi tubuh.
4. Edukasi: Pelatihan kesehatan untuk pasien dan keluarga.
5. Dukungan Sosial: Bantuan untuk aktivitas sosial dan menciptakan lingkungan terapeutik.

G. Jenis Institusi Pemberi Layanan *Home Care*

Ada beberapa jenis institusi yang dapat memberikan layanan *home care*, antara lain:

1. Institusi pemerintah

Pelayanan *home care* di Indonesia, yang telah lama berlangsung dilakukan adalah dalam bentuk perawatan kasus/keluarga resiko tinggi (baik ibu, bayi, balita maupun lansia) yang akan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan puskesmas (digaji oleh pemerintah). Klien yang dilayani oleh puskesmas biasanya adalah kalangan menengah ke bawah. Di Amerika hal ini dilakukan oleh *Visiting Nurse* (VN).

2. Institusi sosial

Institusi ini melaksanakan pelayanan *home care* dengan sukarela dan tidak memungut biaya. Biasanya dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau organisasi keagamaan dengan penyandang dananya dari donatur, misalnya Bala Keselamatan yang melakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang membutuhkan sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan.

3. Institusi swasta

Institusi ini melaksanakan pelayanan *home care* dalam bentuk praktik mandiri baik perorangan maupun kelompok yang menyelenggarakan pelayanan *home care* dengan menerima imbalan jasa baik secara

langsung dari klien maupun pembayaran melalui pihak ke tiga (asuransi). Sebagaimana layaknya layanan kesehatan swasta, tentu tidak berorientasi "*not for profit service*."

4. *Home care* berbasis rumah sakit (*hospital home care*)
Merupakan perawatan lanjutan pada klien yang telah dirawat di rumah sakit, karena masih memerlukan bantuan layanan keperawatan, maka dilanjutkan di rumah. Alasan munculnya jenis program ini selain apa yang telah dikemukakan dalam alasan *home care* di atas, adalah
 - a. Ambulasi dini dengan resiko memendeknya hari rawat, sehingga kesempatan untuk melakukan pendidikan kesehatan sangat kurang (misalnya ibu postpartum normal hanya dirawat 1-3 hari, sehingga untuk mengajarkan bagaimana cara menyusui yang baik, cara merawat tali pusat bayi, memandikan bayi, merawat luka perineum ibu, senam postpartum, dll) belum dilaksanakan secara optimum sehingga kemandirian ibu masih kurang.
 - b. Risiko infeksi nosokomial yang dapat terjadi dapat terhindar seperti pada klien yang dirawat di rumah sakit.
 - c. Penyakit kronis makin bertambah, yang bila dirawat di rumah sakit tentu memerlukan biaya yang besar.
 - d. Kesiambungan perawatan klien dari rumah sakit ke rumah mulai diperlukan, sehingga akan meningkatkan kepuasan klien maupun perawat.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Universitas Padjajaran Bandung di RSHS Bandung menunjukkan bahwa konsumen cenderung menerima program HHC (*Hospital Home Care*) dengan alasan; lebih nyaman, tidak merepotkan, menghemat waktu dan biaya serta lebih mempercepat tali kekeluargaan.

H. Populasi Pemberi Layanan Home Care

1. Populasi layanan

Populasi layanan *home care* di Amerika didominasi oleh wanita (66,8%). Program *home care* diperuntukkan untuk semua umur, tetapi mayoritas klien berusia 65 tahun atau lebih.

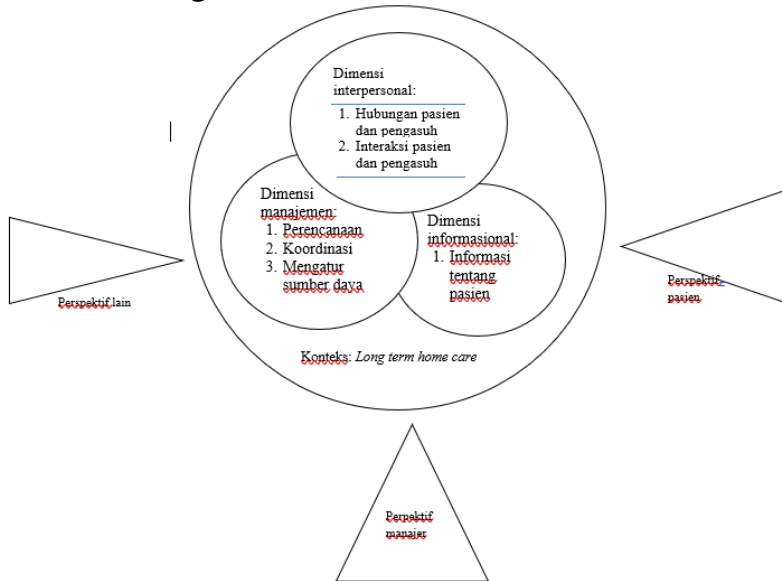
2. Jenis layanan

Home care dalam keperawatan merupakan spesialisasi dari keperawatan komunitas (Blackie, 1998) dalam (Risanto, 2016), maka jenis layanan yang diberikan meliputi layanan keperawatan (diagnosa dan perlakuan terhadap respon manusia yang menghadapi masalah kesehatan baik potensial maupun aktual dalam memenuhi kebutuhan dasarnya) dan layanan kesehatan masyarakat (prevensi primer, sekunder dan tersier). Jenis kasus yang dirawat di rumah adalah:

- a. Penyakit jantung
- b. Penyakit/gangguan sistem muskuloskeletal dan jaringan pengikat
- c. Penyakit Diabetes Mellitus
- d. Penyakit sitem pernafasan

- e. Luka
 - f. Keracunan
 - g. Kanker (hanya sebagian kecil), karena kebanyakan kasus paliatif dirawat di *Hospice*
3. Pemberi layanan
- Pemberi layanan keperawatan di rumah terdiri dari dua jenis tenaga, yaitu:
- a. Tenaga informal
- Tenaga informal adalah anggota keluarga atau teman yang memberikan layanan kepada klien tanpa dibayar. Lanjut usia di Amerika diperkirakan 75% dan dirawat oleh jenis tenaga informal
- b. Tenaga formal
- Tenaga formal adalah perawat yang harus bekerja bersama keluarga untuk menyelesaikan masalah kesehatan, sehingga harus memperhatikan semua aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu perawat di masyarakat dituntut untuk mampu berfikir kritis dan menguasai ketrampilan klinik dan harus seorang *Register Nurse* (RN). Dengan demikian diharapkan perawat dapat memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Risanto, 2016).

I. Model Long Term Home Care



Gambar 2.1 Model Long Term Home Care (Gjevjon, 2014)

Keterangan Gambar:

1. Dimensi Manajemen

Dimensi manajemen merupakan dimensi pemersatu dari dimensi yang lainnya pada interpersonal dan informasional dimensi dalam perawatan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dimensi manajemen memfasilitasi perlunya dimensi interpersonal dan dimensi informasional. Dimensi manajemen ini meliputi perencanaan, koordinasi dan sumber daya manajemen. Perencanaan kegiatan, perencanaan perawatan sangat diperlukan untuk memberikan tindakan yang tepat dan orang yang tepat untuk pasien dengan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Koordinasi dilakukan untuk mengatur perawatan yang diberikan kepada pasien antara lain apabila dilakukan secara primer maka bertanggung jawab terhadap satu orang pasien sampai dengan memonitor keadaan pasien, selain itu dapat dilakukan secara tim dimana anggota tim melakukan kolaborasi, diskusi dan bertanggung jawab terhadap beberapa pasien. Hal ini juga dilakukan koordinasi untuk memastikan informasi yang didapat dari pasien lengkap dan adekuat tentang riwayat pengakit dahulu, sekarang dan prognosis ke depan.

Sumber daya manajemen diperlukan juga untuk keberlanjutan/kontinuitas pelaksanaan *home care* antara lain kondisi dari staf/pengasuh, pengalaman dari pengasuh serta keterampilan dari pengasuh. Oleh karena itu dimensi manajemen mencakup tanggung jawab general untuk dapat merencanakan, koordinasi dan menyiapkan sumber daya untuk dapat melakukan keberlanjutan *home care*.

2. Dimensi interpersonal

Dimensi interpersonal dalam perawatan yang berkelanjutan merupakan hubungan pasien dengan yang merawat atau pengasuh dimana pengasuh memberikan perawatan dan pasien menerima perawatan. Dimensi ini menjadi elemen utama pada perawatan baik di puskesmas, rumah sakit, panti, dan perawatan jangka panjang di rumah. Sesuai dengan gambar, dimensi interpersonal terdiri dari hubungan pasien dengan pengasuh dan interaksi pasien dengan pengasuh.

Dimensi interpersonal memungkinkan hubungan dan interaksi pasien dengan pengasuh baik satu lawan satu, banyak lawan satu, beberapa lawan satu. Interaksi satu pasien dengan satu pengasuh akan menunjukkan kualitas hubungan yang baik dalam keberlanjutannya dan hal ini merupakan hubungan pasien-pengasuh yang ideal. Interaksi satu sama lain antara pasien dan pengasuh akan memupuk kepercayaan dan saling menghargai satu sama lain, akan mendukung stabilitas dan keberlanjutan perawatan. Keberhasilan kegiatan ini adalah hubungan mendalam dari pasien dan pengasuh.

3. Dimensi informasional

Informasi mengenai pasien dapat dijadikan sebagai laporan pasien dalam dokumentasi keperawatan mulai dari aktifitas klien yang dilakukan selama satu hari. Dokumentasi dan informasi dari pasien dapat menjadi bahan untuk data pasien dan dapat digunakan sebagai data penelitian untuk pengembangan pelayanan keperawatan (Gjevjon, 2014)



BAB 5

Kemandirian Lansia Demensia

A. Definisi Kemandirian

Kemandirian adalah suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengatasi hambatan/masalah dengan rasa percaya diri dengan tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, serta mampu memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri tanpa pengaruh lingkungan dan bantuan orang lain.

Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri untuk kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan, serta berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya (Patriana, 2007).

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi individu. Kemandirian diperoleh secara bertahap selama perkembangan berlangsung, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri.

Pengertian Kemandirian dari Para Ahli:

1. Menurut Nurhayati (2011), kemandirian adalah kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.
2. Menurut Kartono (2007), kemandirian adalah kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri.
3. Menurut Chaplin (2002), kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan menentukan dirinya 1. sendiri.
4. Menurut Maryam (2015), kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.
5. Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata

benda. Kemandirian berasal dari kata dasar “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering digunakan atau berdekatan dengan kemandirian adalah autonomy (Desmita, 2017).

6. Menurut Monks, dkk (dalam Astuti, 2013) mengatakan bahwa orang yang mandiri akan memperlihatkan perilaku yang eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya diri dan kreatif. Selain itu juga mampu bertindak kritis, tidak takut berbuat sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan aktifitasnya, mampu menerima realita serta dapat memanipulasi lingkungan, berinteraksi dengan teman sebaya, terarah pada tujuan dan mampu mengendalikan diri.
7. Selanjutnya kemandirian menurut Steinberg (dalam Purbasari, 2016) dapat diartikan sebagai kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai.
8. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan/mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya/diputuskannya, baik dalam segi manfaat atau keuntungannya maupun segi-segi negatif dan

kerugian yang akan dialaminya menurut Basri (dalam Sa'diyah, 2017).

9. Menurut Chaplin (dalam Desmita, 2017), otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bias memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan Seifert dan Hoffinung (dalam Desmita, 2017), mendefinisikan otonomi atau kemandirian sebagai "The ability to govern and regulate one's own thoughts, feelings, and actions freely and responsibly while overcoming feeling of shame and doubt."
10. Erikson (dalam Desmita, 2017), menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan kearah individualitas yang mantap dan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inspiratif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi dimana peserta didik secara relatife bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Kesimpulan Pengertian Kemandirian

Kemandirian merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya.

Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu keadaan pada seseorang untuk mengontrol tindakan diri sendiri, mampu mengambil keputusan sendiri tanpa harus adanya bimbingan orang tua atau orang dewasa lainnya dan mampu melakukan suatu hal untuk dirinya sendiri, memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mempunyai inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, merasa puas dengan hasil usahanya, dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan (Syadiyah, H 2019).

B. Aspek-Aspek Kemandirian

Steinberg (Syadiyah, H, 2019), membedakan karakteristik kemandirian atas tiga bentuk, yaitu:

1. Kemandirian emosional (*emotional autonomy*), yakni aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, seperti hubungan emosional peserta didik dengan guru atau dengan orangtuanya.

2. Kemandirian tingkah laku (*behavioural autonomy*), yakni suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab.
3. Kemandirian nilai (*value autonomy*), yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting.

Aspek-aspek kemandirian adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab, yaitu kemampuan memikul tanggungjawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- b. Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.
- c. Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif.
- d. Kontrol Diri, kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.

Selain itu aspek-aspek pada kemandirian lansia demensia pada kompetensi:

1. Komunikasi verbal

a. Tips komunikasi verbal pada lansia demensia

Persiapkan hati yang positif pada saat berinteraksi. Sikap dan bahasa tubuh Anda dalam mengkomunikasikan sesuatu akan lebih kuat daripada menggunakan kata-kata. Dengan suasana hati yang positif ketika berbicara dengan warga dengan demensia, Anda dapat berbicara dengan cara yang menyenangkan dan penuh rasa hormat. Gunakan nada suara yang halus, ekspresi wajah yang ramah, hingga sentuhan fisik untuk membantu penyampaian pesan dan tunjukan dengan rasa penuh kasih sayang.

b. Dapat perhatiannya saat berkomunikasi

Upayakan fokus perhatian warga dengan demensia, dan lakukan komunikasi di ruangan yang terbatas dari gangguan dan kebisingan, misalnya dengan mematikan TV, menutup pintu, ataupun pindah ke area yang lebih tenang. Pastikan Anda mendapat perhatiannya sebelum berbicara. Identifikasi diri Anda dengan mengingatkan pada beliau nama Anda dan relasinya, gunakan isyarat nonverbal hingga sentuhan untuk membantu warga demensia agar tetap fokus. Jika beliau dalam posisi duduk, turun ke levelnya dan pertahankan kontak mata dengannya.

c. Sampaikan pesan dengan jelas

Ketika berkomunikasi dengan warga dengan demensia, gunakan kata dan kalimat yang sederhana. Berbicara dengan pelan, jelas dan dengan menggunakan intonasi yang meyakinkan. Tidak perlu meninggikan suara ataupun membuat lebih keras; sebagai gantinya

ganti suara Anda menjadi lebih rendah. Gunakan kata-kata yang sama untuk mengulang pesan ataupun pertanyaan Anda jika beliau tidak mengerti pertama kali. Selalu gunakan nama orang dan tempat dengan tidak mengganti kata (mis. dia, itu, mereka, di sana) ataupun dengan singkatan.

- d. Gunakan pertanyaan yang sederhana yang bisa dijawab

Ajukan satu pertanyaan pada satu waktu; mendapatkan jawaban ya atau tidak dari mereka sudah cukup baik. Jangan terlalu mengajukan pertanyaan terbuka atau dengan memberi banyak pilihan.

- e. Dengarkan warga demensia dengan telinga, mata dan hati

Bersabar dalam menunggu jawaban dari warga dengan demensia. Jika dia berusaha mencari jawaban sendiri, tidak masalah untuk membantu mencari kata yang tepat. Selalu perhatikan isyarat non verbal dan bahasa tubuh serta tanggapilah dengan tepat.

- f. Ketika keadaan menjadi lebih sulit, coba untuk mengalihkan perhatian mereka.

Penting diingat bahwa menjalin hubungan dengan warga demensia perlu dilakukan pada tingkat perasaan. Sebelum Anda mengalihkan perhatian, mungkin Anda dapat berkata, "Bapak kelihatannya sedang sedih – ayo kita cari hiburan yang menyenangkan".

- g. Tanggapi senior demensia dengan penuh kasih sayang dan kepastian

Warga demensia sering merasa kebingungan, cemas dan tidak yakin pada diri sendiri. Lebih jauh, mereka

sering mendapatkan kenyataan yang membingungkan dan mungkin mengingat hal-hal yang tidak pernah terjadi. Hindari mencoba meyakinkan mereka bahwa mereka salah. Tetap fokus pada perasaan yang mereka tunjukkan dan ekspresikan dengan sikap yang positif. Pertahankan selera humor Anda dan gunakan humor kapanpun memungkinkan. Warga dengan demensia cenderung masih mempertahankan kemampuan sosial mereka dan biasanya masih senang tertawa dan bersenda gurau bersama.

2. ADL

a. Jalan Kaki

Lansia tidak bisa melakukan aktivitas berat, karena itu olahraga seperti jalan kaki sangat disarankan. Tidak hanya menjaga stamina, jalan kaki juga minim resiko karena tak menyebabkan cedera. Bagi lansia yang mengalami demensia, jalan kaki bisa dilakukan sekitar 20 – 60 menit dalam 3 kali seminggu.

b. Kegiatan Rumah Tangga

Melakukan kegiatan rumah tangga sederhana juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh lansia. Meski sederhana, kegiatan rumah tangga juga bisa melatih konsentrasi serta koordinasi fisik. Agar mengurangi kemungkinan cedera, ajak anggota keluarga lain untuk melakukan aktivitas rumah tangga bersama, misalnya berkebun atau membuat camilan.

c. Senam Aerobik

Senam aerobik termasuk salah satu senam yang ringan dan cocok dilakukan oleh orang tua. Jenis senam ini juga bisa dilakukan secara teratur, antara 3 – 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Dengan melakukan

senam aerobik, tubuh lansia bisa mendapatkan aliran darah yang cukup, terutama area otak.

d. Meditasi

Meditasi memang bukan aktivitas yang bisa meningkatkan kemampuan otak secara aktif, tapi meditasi bisa menjaga kesehatan mental lansia. Aktivitas meditasi yang dilakukan secara rutin juga mampu mencegah kemungkinan depresi akibat penurunan daya pikir.

e. Melakukan Permainan Asah Otak

Ada banyak jenis permainan asah otak, mulai dari catur, teka teki silang, hingga permainan papan. Permainan ini secara efektif bisa menjaga kemampuan otak, terutama bagian daya ingat dan konsentrasi. Memainkan permainan ini juga menjadi media yang menyenangkan untuk berkomunikasi antara lansia demensia dengan anggota keluarga lain.

f. Belajar Alat Musik

Kegiatan non fisik seperti belajar alat musik ternyata dianjurkan untuk penderita demensia, karena mencakup kerja otak yang lebih luas. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan belajar alat musik, mulai dari meningkatkan kemampuan motorik halus hingga meningkatkan kemampuan penglihatan, suara dan ingatan.

g. Aqua Aerobic

Selain berolahraga ringan, jika kemampuan fisik lansia masih dalam keadaan baik, penderita lansia disarankan untuk berlatih dalam air. Keberadaan air dapat mengurangi beban tubuh, sehingga membuat gerak sandi menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

h. Mempelajari Bahasa Baru

Struktur otak terdiri dari sel saraf dan dendrit, yang sering juga disebut sebagai materi abu-abu. Seseorang yang mempelajari dua bahasa atau lebih, sel saraf ini bersifat lebih pekat dan bisa mendorong proses pikir. Dengan mempelajari bahasa baru, terdapat peningkatan fungsi otak yang bisa membantu penderita demensia agar lebih berkonsentrasi pada keseharian mereka.

C. Jenis Kemandirian

1. Kemandirian aman (*secure autonomy*), yaitu kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih pada dunia, kehidupan, dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama, dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan. Kekuatan ini digunakan untuk mencintai kehidupan dan membantu orang lain.
2. Kemandirian tidak aman (*insecure autonomy*), yaitu kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku menentang dunia. Kondisi seperti ini sebagai selfish autonomy atau kemandirian mementingkan diri sendiri.

D. Karakteristik Kemandirian

Menurut Desmita (2011), berdasarkan karakteristiknya kemandirian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Kemandirian remaja dalam aspek emosional ditunjukkan dengan tiga hal yaitu tidak bergantung secara emosional dengan orang tua

namun tetap mendapat pengaruh dari orang tua, memiliki keinginan untuk berdiri sendiri, dan mampu menjaga emosi di depan orang tuanya.

2. Kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian remaja dalam tingkah laku memiliki tiga aspek, yaitu perubahan kemampuan dalam membuat keputusan dan pilihan, perubahan dalam penerimaan pengaruh orang lain, dan perubahan dalam merasakan pengendalian pada dirinya sendiri (self-resilience).
3. Kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Kemandirian nilai merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh remaja, menyangkut baik-buruk, benar-salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama.

E. Bentuk-Bentuk Kemandirian

1. Kemandirian Emosi. Merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain.
2. Kemandirian Ekonomi. Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain.
3. Kemandirian Intelektual. Kemandirian intelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

4. Kemandirian Sosial. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain.

F. Ciri dan Tingkatan Kemandirian

Kemandirian pada seseorang terus mengalami peningkatan sesuai dengan usia perkembangan. Menurut Desmita (2011), ciri-ciri kemandirian berdasarkan tingkatannya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertama (impulsif dan melindungi diri)
Pada tingkat pertama, individu biasanya bertindak secara spontanitas tanpa berfikir terlebih dahulu. Adapun kemandirian pada tingkat pertama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain.
 - b. Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik.
 - c. Berfikir tidak logis dan tertegun pada cara berfikir tertentu.
 - d. Cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games.
 - e. Cenderung menyalahkan orang lain dan mencela orang lain serta lingkungannya.
2. Tingkat kedua (konformistik)
Pada tingkat kedua ini seseorang cenderung mengikuti penilaian orang lain. Adapun Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial.
 - b. Cenderung berfikir stereotip dan klise.

- c. Peduli dan konformatif terhadap aturan eksternal.
 - d. Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian.
 - e. Menyamar diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi.
 - f. Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri eksternal.
 - g. Takut tidak diterima kelompok.
 - h. Tidak sensitif terhadap keindividuan.
3. Tingkat ketiga (sadar diri)
- Pada tingkat ini individu mulai menjalani proses mengenali kepribadian dalam diri. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
- a. Mampu berfikir alternatif.
 - b. Melihat berbagai harapan dan kemungkinan dalam situasi.
 - c. Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada.
 - d. Menekan pada pentingnya memecahkan masalah.
 - e. Memikirkan cara hidup.
4. Tingkat keempat (saksama/*conscientious*)
- Pada tingkat keempat ini, individu mulai mampu melihat keragaman emosi dan menilai diri sendiri. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
- a. Bertindak atas dasar-dasar nilai internal.
 - b. Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan.
 - c. Mampu melihat keragaman emosi.
 - d. Sadar akan tanggung jawab.
 - e. Mampu melakukan kritik dan penilaian diri.
 - f. Peduli akan hubungan mutualistik.
 - g. Cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial.
 - h. Berfikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitis.

5. Tingkat kelima (individualitas)

Pada tingkatan ini seseorang mulai memiliki kepribadian yang dapat membedakan diri dengan orang lain. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran individualitas.
- b. Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan.
- c. Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain.
- d. Mengenal eksistensi perbedaan individual.
- e. Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam sebuah kehidupan.
- f. Membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya.
- g. Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Kemandirian bukanlah semata-mata merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungannya, selain potensi yang telah dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari orang tuanya. Menurut Ali dan Asrori (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian adalah:

1. Gen atau keturunan orang tua

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa

sesungguhnya bukan sikap kemandirian orang tuanya itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya.

2. Pola asuh orang tua

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Demikian juga, orang tua yang cenderung sering membandingkan anak yang satu dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian anak.

3. Sistem pendidikan di sekolah

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian remaja. Demikian juga, proses pendidikan yang banyak menekankan pentingnya pemberian sanksi atau hukuman (punishment) juga dapat menghambat perkembangan kemandirian remaja. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetisi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian remaja.

4. Sistem kehidupan di masyarakat

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian remaja.

Kemandirian lansia demensia dapat dipertahankan dengan dukungan keluarga melalui *home care* (perawatan di rumah) yang adaptif, stimulasi kognitif, dan membantu aktivitas sehari-hari (ADL) secara bertahap, sambil menjaga keselamatan dan keseimbangan antara kemandirian dan keamanan untuk membangun rasa percaya diri dan martabat penderita demensia, serta memastikan lingkungan yang aman.

H. Strategi Mendukung Kemandirian

Kemandirian bukanlah semata-mata merupakan pembawaan sehingga diperlukan strategi untuk mendukung kemandirian lansia Demensia antara lain:

1. Dukungan Keluarga (*Home Care*):
 - a. Bantu Bertahap: Bantu lansia melakukan tugas seperti mandi, berpakaian, makan, atau mobilisasi dengan memberikan waktu ekstra dan arahan verbal, jangan langsung mengambil alih.

- b. Pelatihan Pengasuh: Keluarga bisa mengikuti pelatihan *home care* untuk meningkatkan kemampuan perawatan yang tepat dan memahami kebutuhan lansia.
 - c. Motivasi: Dorong lansia untuk melakukan sebanyak mungkin sendiri untuk menjaga rasa mampu.
2. Aktivitas dan Stimulasi:
- a. Tetap Aktif: Dorong hobi, interaksi sosial, dan aktivitas fisik ringan (seperti jalan kaki dengan teman) untuk menjaga fungsi otak dan fisik.
 - b. Stimulasi Kognitif: Latihan membaca, interaksi, dan aktivitas spiritual dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif.
3. Adaptasi Lingkungan dan Keselamatan:
- a. Lingkungan Aman: Pastikan alarm kebakaran terpasang, hindari senjata api, dan waspada saat memasak atau mengemudi (jika masih aman).
 - b. Hindari Jatuh: Jaga jalur jalan yang familiar dan hindari tersesat.
4. Dampak Psikologis:
- a. Tujuan dan Martabat: Melakukan tugas familiar dan membuat keputusan membantu lansia merasa lebih waspada, bermartabat, dan terhubung.
 - b. Sabar: Perkembangan demensia bervariasi, kesabaran sangat penting saat membantu tugas sehari-hari.
- (Desmita, 2011)

BAB 6

***Home Care* Mendukung Kemandirian**

Kemampuan keluarga melakukan *home care* berpengaruh terhadap kemandirian lansia Demensia. Namun kemandirian lansia Demensia dipengaruhi oleh kemampuan keluarga melakukan *home care* sebesar 29,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain kemampuan keluarga melakukan *home care*.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Naganathan, 2016) beberapa kondisi kronis meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia dan kondisi ini sering menyebabkan perawatan kesehatan dengan biaya perawatan kesehatan cukup besar. Tantangan untuk merawat lansia akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Dukungan sosial telah terbukti meningkatkan hasil kesehatan lansia di beberapa bidang termasuk kesehatan mental, fungsi kognitif, kualitas hidup, menekan morbiditas dan mortalitas.

Model pemberian layanan kesehatan yang menekankan dan memasukkan dukungan sosial keluarga telah terbukti menurunkan pengeluaran biaya layanan kesehatan dan meningkatkan manfaat untuk lansia. Sistem perawatan berbasis rumah dan komunitas adalah salah satu model

yang menyediakan layanan kesehatan dan dukungan sosial termasuk dukungan emosional atau instrumental, termasuk bantuan untuk aktivitas hidup sehari-hari (ADL) seperti makan dan mandi, transportasi.

Mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan hidup dengan kekuatan sendiri, adanya kepercayaan terhadap ide-ide diri sendiri, tidak ada keraguan dalam menetapkan tujuan, tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan. Kemandirian berkenaan dengan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas, tidak bergantung pada orang lain dalam keputusan dan mampu melaksanakan tugas hidup dengan penuh tanggung jawab.

Kemandirian memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri untuk kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan, serta berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Di samping itu kemandirian menunjukkan kemampuan berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya (Roehadi, 2018).

Hasil penelitian lain didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian lansia antara lain ketergantungan 63,8% dalam melakukan ADL, resiko mudah terjatuh 57,5%, faktor penyakit 58,8%. Timbulnya ketergantungan dalam melakukan ADL pada lansia dapat disebabkan oleh beberapa etiologi seperti umur, kesehatan

fisiologis, fungsi kognitif, dan fungsi psikososial (Marlita L, 2018).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian lansia menurut Parker dalam Roehadi, 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab berarti memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta pertanggung jawaban atas hasil kerjanya. Misalnya lansia diberi tanggung jawab dimulai dengan tanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri akan merasa dipercaya, berkompeten dan dihargai.
2. Percaya diri dan mandiri adalah dua hal yang saling menguatkan. Semakin lansia dapat mandiri, dia akan semakin mampu mengelola kemandirian, kemudian mengembangkan kemandirian. Keluarga harus memberikan kesempatan dan waktu agar lansia bisa memiliki tugas-tugas yang praktis, mereka harus memahami metode atau cara bagaimana menyelesaikan dan bagaimana menghadapi frustrasi yang tidak bisa dihindarkan.
3. Pengalaman praktis dan akal sehat yang relevan. Akal sehat berkembang melalui pengalaman yang praktis dan relevan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara mandiri seperti makan untuk dirinya sendiri, membuat keputusan rasional bagaimana membelanjakan uang sesuai kebutuhan, menggunakan sarana transportasi umum dan menyebrang jalan, kreasi secara cepat dan tepat dalam berbagai situasi darurat.
4. Otonom merupakan kemampuan untuk menentukan arah sendiri (*selfdetermination*) yang berarti mampu mengendalikan atau mengetahui atau mempengaruhi apa yang terjadi pada dirinya.

Disamping itu faktor yang mempengaruhi kemandirian lansia antara lain:

5. Kemampuan memecahkan masalah, lansia akan terdorong untuk mencari jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang mereka alami,
6. Kebutuhan akan kesehatan yang baik. Olah raga dan berbagai aktifitas fisik adalah penting untuk mengembangkan atau meningkatkan proses koordinasi yang baik dan kebugaran. Kita semua tahu bahwa latihan dapat memberi keuntungan dan berpengaruh terhadap kesehatan kita dan kebahagiaan secara umum. Latihan dapat memberi energi yang baru dan dianggap dapat meningkatkan sikap dan motivasi kita, maka jika tubuh kita bugar, kita akan memiliki stamina yang lebih baik.
7. Support sosial terdiri dari jaringan informal (keluarga dan teman), sistem pendukung formal (tim keamanan sosial setempat, program medikasi, kesejahteraan sosial), dukungan-dukungan semiformal (bantuan dan interaksi organisasi lingkungan sekitar).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kemandirian lansia Demensia selain dipengaruhi oleh support sosial dari *home care* yang dilakukan oleh keluarga, faktor lain juga mendukung adanya kemandirian lansia tersebut termasuk di dalamnya rasa tanggung jawab lansia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, pengalaman yang dimiliki lansia, rasa percaya diri akan kemampuan/potensi, otonomi yang tinggi, kondisi kesehatan fisik.

Hal ini akan mendorong lansia untuk tetap bersemangat melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga kemandirian lansia Demensia akan baik apabila didukung dengan support dari internal diri sendiri dan eksternal termasuk keluarga dan teman.

Kemandirian lansia demensia pada hasil pre dan post test kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menunjukkan terdapat perbedaan antara keduanya, demikian juga apabila dibandingkan antara post perlakuan dengan post kelompok kontrol, terdapat perbedaan antara keduanya sehingga dapat dikatakan adanya pengaruh intervensi home care oleh keluarga terhadap kemandirian lansia demensia.

Kemandirian lansia demensia terdiri dari 4 indikator dan setiap indikator menunjukkan adanya peningkatan dari nilai sebelum intervensi ke nilai setelah intervensi khususnya pada kelompok perlakuan. Indikator komunikasi verbal, ADL, kognitif dan perilaku terjadi peningkatan angka setelah dilakukan intervensi *home care*, dimana ADL mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Sedangkan pada kelompok kontrol, menunjukkan hasil tidak ada perbedaan hasil pre dan post test serta perbandingan kelompok perlakuan dan kontrol.

Activuty Daily Living (ADL) lansia dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari lansia demensia dalam upaya ke arah kemandirian lansia demensia tersebut. Hal ini tidak melalui upaya atau usaha keras untuk memenuhinya serta dilakukan sesuai dengan kemampuan lansia demensia seperti: mandi, berpakaian, makan, atau mobilisasi. Keluarga

mendampingi dan memotivasi lansia untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri meskipun bertahap.

Kesulitan komunikasi verbal, penurunan kemampuan kognitif dan perilaku agresif termasuk *behaviour and psychological symptoms of dementia* (BPSD) terdiri dari gejala perilaku (disinhibisi perilaku, agitasi fisik, agitasi verbal, wandering, amarah), gejala psikologis (mood: depresi, apatis, kecemasan; gejala psikotik: delusi, halusinasi, salah identifikasi), dan kepribadian berubah dimana disebabkan oleh neuropatologi dan gangguan neurotransmitter. Lesi neuropatologis menyebabkan berkurangnya sel neuron untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga memberikan dampak klinis yang terlihat pada perilaku dan psikologis lansia dengan demensia (Lueckenotte, 2000) .

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Fungsi kemandirian pada lansia mengandung pengertian yaitu kemampuan yang dimiliki oleh lansia untuk tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitasnya, semuanya dilakukan sendiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Roehadi, 2018).

Menurut penelitian di Taiwan, dengan menggunakan Inventarisasi Agitasi Cohen-Mansfield China. Analisis item dan faktor mengeksplorasi dan mengklasifikasikan perilaku agitasi lansia demensia menjadi 5 sub tipe utama: perilaku agitasi fisik, perilaku destruktif, perilaku agitasi verbal, perilaku penanganan sesuatu, dan perilaku agresif (Huang, Shyu and Hsu, 2018).

Penelitian lain juga menyebutkan terapi modifikasi untuk lansia demensia. Lansia demensia berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah dan melakukan kegiatan berbasis alam. Lima jenis kegiatan berbasis alam antara lain:

- 1) layanan yang diberikan oleh wirausahawan sosial,
- 2) membuka kebun untuk penderita Demensia,
- 3) mendirikan organisasi perawatan sosial berbasis alam,
- 4) mendirikan taman komunitas oleh warga, dan
- 5) inisiatif hibrida.

Kegiatan yang biasa dilakukan adalah berkebun, merawat hewan, menyiapkan makanan, dan merawat hewan ternak, kegiatan rekreatif seperti duduk dan berjalan di taman, menghadiri presentasi dan tamasya.

Tantangan umum termasuk ketersediaan ruang kota hijau, pendanaan untuk layanan berbasis alam, kurangnya komitmen, keterlibatan tinggal di rumah dan kurangnya interaksi dengan lingkungan. Inisiatif dikembangkan dalam menghadapi berbagai jenis tantangan yang berorientasi pada perawatan seperti membuka fasilitas taman dan terapi rekreatif (Hassink *et al.*, 2019).

Kemandirian lansia demensia dicapai melalui suatu proses yang terarah. Perkembangan menuju kemandirian dan kebebasan pribadi secara normal berkembang hingga pada saat apabila lansia telah mencapai kebebasan secara emosional, finansial dan intelektual. Kemandirian lansia berkembang dengan baik dikarenakan diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan usia dan kemampuan lansia sehingga apabila dihayati semakin berkembang menuju kesempurnaan.

Menurut Roehadi (2018) tahap-tahap kemandirian bisa digambarkan sebagai berikut: 1) Mengatur kehidupan dan diri mereka sendiri, misalnya: makan, ke kamar mandi, mencuci, membersihkan gigi, memakai pakaian dan lain sebagainya; 2) Melaksanakan gagasan-gagasan sendiri dan menentukan arah permainan mereka sendiri; 3) Mengurus hal-hal di dalam rumah dan bertanggung jawab; 4) Mengatur dirinya sendiri di luar rumah, misalnya: di masyarakat; 5) Mengurus orang lain baik di dalam maupun di luar rumah, misalnya menjaga saudara ketika orang tua sedang di luar rumah.

Lansia demensia dilakukan survey tentang perilaku psikologisnya. Secara keseluruhan, gejala *dysphoric* yang paling umum pada orang dengan gangguan kognitif sedang. Namun, gejala *dysphoric* sedang sampai berat tidak menunjukkan variasi yang jelas dengan gangguan kognitif. Lebih lanjut, perilaku agresif, perilaku mengganggu/mencari perhatian secara verbal, gejala halusinasi dan perilaku

mengembara lebih umum dengan disforia bersamaan terlepas dari fungsi kognitif. Apatis lebih sering dikaitkan dengan disforia bersamaan pada tahap awal penurunan kognitif tetapi tidak pada tahap selanjutnya, menunjukkan bahwa apatis dan disforia mewakili sindrom terpisah di antara pasien usia lanjut dengan gangguan kognitif sedang hingga berat (Lindbo *et al.*, 2017).

Penderita demensia menunjukkan beberapa gangguan yaitu gangguan kognitif dan memori, perubahan tingkah laku harian baik mengganggu maupun yang tidak mengganggu. Hal ini memerlukan perawatan untuk menjaga ketajaman daya ingat dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak.

Menurut Alphen (2016) perawatan demensia diutamakan mengarah ke kemandirian dan dilakukan beberapa terapi antara lain:

1. Segi kognitif, lansia demensia dapat melakukan kegiatan membaca gunanya merangsang fungsi otak untuk berpikir yang dilakukan setiap hari,
2. Segi spiritual, lansia melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing,
3. Segi interaksi sosial, lansia tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul bersama teman, mengurangi stres dan tetap rileks.



BAB 7

Penutup

Home care adalah pelayanan kesehatan profesional yang komprehensif dan berkesinambungan diberikan langsung di rumah pasien, bertujuan meningkatkan kemandirian, meminimalkan dampak penyakit, serta melibatkan keluarga untuk promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai solusi mengatasi keterbatasan fasilitas rumah sakit dengan pendekatan multidisiplin dan berfokus pada kebutuhan individu serta konteks budaya pasien.

Layanan *home care* mulai menjadi perhatian untuk dikembangkan guna meningkatkan kemandirian lansia demensia. Apabila *home care* dilakukan dan dimanajemen secara efektif akan dapat meningkatkan kemandirian baik bagi pasien maupun bagi pemberi asuhan (keluarga), hal ini juga dapat mendukung perkembangan yang baik bagi kognitif dan fungsi fisik pasien. Penelitian yang dilakukan di tahun 2014, membuktikan bahwa pasien dewasa tua yang dilakukan perawatan di rumah dilaporkan memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi dan tingkat kesepian serta tingkat stres yang rendah, dibanding yang tidak dilakukan.

Untuk mempertahankan kemandirian dan meningkatkan prognosis lansia demensia diperlukan perawatan yang melibatkan keluarga atau dilakukan berkelanjutan dan tidak terputus.

Kemandirian lansia demensia dapat dipertahankan dengan dukungan keluarga melalui *home care* (perawatan di rumah) yang adaptif, stimulasi kognitif, dan membantu aktivitas sehari-hari (ADL) secara bertahap, sambil menjaga keselamatan dan keseimbangan antara kemandirian dan keamanan untuk membangun rasa percaya diri dan martabat penderita demensia, serta memastikan lingkungan yang aman

Daftar Pustaka

- Barker S, B. M. (2019). *Penanganan Demensia dalam Keperawatan*. Yogyakarta: Ripha Publisher.
- Desmita. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mawaddah, N & Wijayanto, A. 2020. Peningkatan Kemandirian Lansia Melaluiactivity Daily Living Training Dengan Pendekatankomunikasi Terapeutikdi Rsj Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. *ejournal.stikesmajapahit.ac.id*
- Oing Chao, et all, 2020. The Prevalence of Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Alzheimer's Disease* Volume 73, Issue 3. SAGE Publications
- Hassink, J, Vaandrager, Buist, Bruin (2019) 'Characteristics and challenges for the development of nature-based adult day services in urban areas for people with dementia and their family caregivers', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(8). doi: 10.3390/ijerph16081337.
- Lindbo, A, Gustafsson, Isaksson, Sandman, Lövheim (2017) 'Dysphoric symptoms in relation to other behavioral and psychological symptoms of dementia, among elderly in nursing homes', *BMC Geriatrics*, 17(1), pp. 1–9. doi: 10.1186/s12877-017-0603-4.
- Lueckenotte, A. G. (2000) *Gerontologic Nursing*. United States of Amerika: Mosby.
- Huang, Shyu, Hsu. (2018) 'Agitated behaviors among elderly people with dementia living in their home in Taiwan', *Clinical interventions in aging*, 13, p. 1193.
- Padila (2013) *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Ratnawati. 2017. *Keperawatan Komunitas*. Yogyakarta. TIM
- Risanto, E. (2016) *Home Care Nursing*. EGC Jakarta.
- Roehadi (2018) 'Determinants Activity of Daily Living Erderly', *Journal of Ultimate Public Health*.
- Umegaki, H. Asai, Kanda, Maeda, Shimojima, Nomura, Kuzuya (2016) 'Risk factors for the discontinuation of home medical care among low-functioning older patients', *Journal of Nutrition, Health and Aging*, 20(4), pp. 453–457. doi: 10.1007/s12603-015-0606-9.
- Vega Dela, S. F, Corderob , Palaparc , Garciad , Agapito (2018) 'Mixed-methods research revealed the need for dementia services and Human Resource Master Plan in an aging Philippines', *Journal of Clinical Epidemiology*, 102, pp. 115–122. doi: 10.1016/j.jclinepi.2018.06.010.

Glosarium

Activity Daily Living (ADL)	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya pada lansia demensia dalam upaya menuju kemandirian lansia demensia.
Aqua Aerobic	Kegiatan latihan fisik di dalam air yang dapat mengurangi beban tubuh sehingga gerakan sendi menjadi lebih mudah untuk dilakukan.
Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)	Gejala perilaku dan psikologis pada lansia demensia meliputi perilaku agresif (disinhibisi perilaku, agitasi fisik dan verbal, wandering, amarah), gejala psikologis (depresi, apatis, kecemasan), gejala psikotik (delusi, halusinasi, salah identifikasi), serta perubahan kepribadian akibat neuropatologi dan gangguan neurotransmitter.
Demensia	Istilah umum untuk menggambarkan kerusakan fungsi kognitif global yang bersifat progresif dan memengaruhi aktivitas sosial serta okupasi dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat disebabkan oleh Alzheimer, gangguan vaskuler, Parkinson, alkoholisme kronis, penyakit Pick, Huntington, dan AIDS.
Home Care	Pelayanan kesehatan profesional yang komprehensif dan berkesinambungan yang diberikan di rumah pasien untuk meningkatkan kemandirian, meminimalkan dampak penyakit, melibatkan keluarga dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan pendekatan multidisiplin dan berfokus pada kebutuhan individu serta konteks budaya.

Kemandirian	Kemampuan seseorang untuk mengelola dirinya sendiri, termasuk mengatur waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri, serta mampu mengambil risiko dan memecahkan masalah.
Long Term Care	Perawatan jangka panjang bagi lansia demensia yang mengalami penurunan fungsi kognitif, aktivitas sosial, dan aktivitas sehari-hari seperti toileting, berdandan, dan makan.
Meditasi	Praktik melatih pikiran untuk meningkatkan fokus, kesadaran diri, dan relaksasi melalui pengaturan napas, pengulangan mantra, atau pemusatan perhatian dengan tujuan mencapai ketenangan batin, mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik.
Otonom	Kemampuan menentukan arah sendiri (self-determination), yaitu mampu mengendalikan, mengetahui, dan memengaruhi apa yang terjadi pada dirinya.
Senam Aerobik	Latihan fisik ringan yang cocok untuk lansia dan dapat dilakukan secara teratur 3–5 kali per minggu selama ±30 menit dengan tujuan meningkatkan aliran darah, terutama ke area otak.

Profil Penulis



**Dr. Hidayatus Sya'diyah,
S.Kep., Ns., M.Kep.,**

Lahir di Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 1979. Telah menyelesaikan pendidikan Program S1 Keperawatan pada tahun 2004 dan Program pascasarjana Magister Keperawatan pada tahun 2008 di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

Selanjutnya menyelesaikan gelar Doktor di Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tahun 2022. Saat ini aktif dalam kepengurusan AIPNI Jawa Timur Periode 2022-2026 Bidang uji kompetensi dan pemberdayaan lulusan serta mendapatkan amanah sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKES Hang Tuah Surabaya periode tahun 2021 s/d sekarang. Aktif mengajar pada Mata Kuliah Komunikasi Keperawatan, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Komunitas dan Keluarga. Produk buku yang telah dihasilkan antara lain Komunikasi Keperawatan (*Communication Games Application*) di tahun 2013, Keperawatan Lanjut Usia di tahun 2019 dan Komunikasi Terapeutik di tahun 2023 serta berbagai Book Chapter terkait kelompok keilmuan keperawatan yang saya ampu.

Email: hidayatussyadiah@stikeshangtuah-sby.ac.id

hidayatussyadiah@gmail.com

mahisyah_sht@yahoo.com

Sinopsis

Home care merupakan pemberian layanan keperawatan di rumah mencakup layanan dan pemberian produk untuk klien yang diperlukan untuk mempertahankan, memulihkan, meningkatkan kesehatan fisik, psikologis dan sosial. Fokus keperawatan kesehatan di rumah adalah individu dan keluarga mereka di rumah menjadi teritori keluarga, isu kekuatan dan kendali dalam pemberian asuhan. Kebutuhan perawatan di rumah dapat diidentifikasi oleh siapapun yang terlibat dengan klien

Home care memberikan pelayanan kesehatan profesional yang komprehensif dan berkesinambungan dan diberikan langsung di rumah pasien, bertujuan meningkatkan kemandirian, meminimalkan dampak penyakit, serta melibatkan keluarga untuk promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai solusi mengatasi keterbatasan fasilitas rumah sakit dengan pendekatan multidisiplin dan berfokus pada kebutuhan individu serta konteks budaya pasien.

Home care berpengaruh terhadap kemandirian lansia Demensia. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa kondisi kronis meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia dan kondisi ini sering menyebabkan perawatan kesehatan dengan biaya perawatan kesehatan cukup besar. Tantangan untuk merawat lansia akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Dukungan sosial keluarga telah terbukti meningkatkan hasil kesehatan lansia di beberapa bidang termasuk kesehatan mental, fungsi kognitif, kualitas hidup, menekan morbiditas dan mortalitas.

Home care merupakan pemberian layanan keperawatan di rumah mencakup layanan dan pemberian produk untuk klien yang diperlukan untuk mempertahankan, memulihkan, meningkatkan kesehatan fisik, psikologis dan sosial. Fokus keperawatan kesehatan di rumah adalah individu dan keluarga mereka di rumah menjadi teritori keluarga, isu kekuatan dan kendali dalam pemberian asuhan. Kebutuhan perawatan di rumah dapat diidentifikasi oleh siapapun yang terlibat dengan klien

Home care memberikan pelayanan kesehatan profesional yang komprehensif dan berkesinambungan dan diberikan langsung di rumah pasien, bertujuan meningkatkan kemandirian, meminimalkan dampak penyakit, serta melibatkan keluarga untuk promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai solusi mengatasi keterbatasan fasilitas rumah sakit dengan pendekatan multidisiplin dan berfokus pada kebutuhan individu serta konteks budaya pasien.

Home care berpengaruh terhadap kemandirian lansia Demensia. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa kondisi kronis meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia dan kondisi ini sering menyebabkan perawatan kesehatan dengan biaya perawatan kesehatan cukup besar. Tantangan untuk merawat lansia akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Dukungan sosial keluarga telah terbukti meningkatkan hasil kesehatan lansia di beberapa bidang termasuk kesehatan mental, fungsi kognitif, kualitas hidup, menekan morbiditas dan mortalitas.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-83-7 (PDF)



9

786347

556837

